第十章 健康管理及实施策略


本章数字资源

学习提要

- 健康管理具有相应的内涵，体现出全科医学思维。
- 健康管理的实施策略包含：收集健康信息、评估健康危险因素、开展健康指导、干预健康危险因素以及监测健康状况。
- 开展健康管理须关注到亚健康状态和各类重点人群。
- 主动健康管理强调个体的主观能动性以及主动获得持续健康的能力，是一种更加积极、全面和科学的健康管理理念。
- 开展健康管理是全科医生的重要工作职能和岗位职责，在维护群体健康和开展社区慢性病管理中发挥着重要作用。通过整合社区相关资源开展更多健康管理相关服务。
- 健康管理在过程环节、供需协同、技术发展、市场监管和人才建设等方面都面临挑战，同时也具备更多发展前景。

健康管理（health management）兴起于20世纪80年代，发展至今已作为国家或国际组织全民健康促进战略规划的重要项目。全科医学与健康管理具有密切的相关性，在全科医学思维引导下开展健康管理服务是全科医生需要具备的重要能力。

第一节 | 健康管理概述

一、健康管理的概念和内涵

（一）健康管理的定义

健康管理是指以不同健康状态下人们的健康需要为导向，通过对个人和群体的健康状况及影响健康的危险因素进行全面检测、分析、评估及预测，向人们提供有针对性的健康咨询和指导服务，并制订健康管理计划，协调社会、组织和个人的行为，针对所有健康相关危险因素进行系统性的干预和管理的全过程。

健康管理是对个体或群体健康相关危险因素的全面性管理，其宗旨是要调动个人以及群体的积极性，对有限的资源进行充分有效的利用以达到最大的健康效果。

（二）全科医学思维与健康管理

全科医学是一门以人为中心、家庭为单位、社区为范围，整合了临床医学、预防医学、康复医学及人文社会学等多学科，并提供连续、综合、协调和个性化医疗服务的综合性医学学科。全科医学思维包含以人为中心、整体观和系统论等要素。基于全科医学学科特点及思维要素，全科医生要注重对健康和疾病相关现象和问题的总体认识，强调人的躯体、心理和社会三个方面的相互作用；对个体及人群的医疗服务要涵盖系统性的疾病预防、诊疗和康复，开展健康和疾病的管理要涵盖全生命周期，并考虑个体及人群的意愿和需求，实行共同决策。

健康管理与个人、家庭和社区之间有着密切的关系。在社区开展健康管理服务，其对象既可以是

个体，也可以包括社区内全体居民，或是需要重点关注的慢性病患者、老年人、妇女、儿童等特定人群。在具体开展健康危险因素评估及干预方面，需要注意到家庭和社区的因素。

基于全科医学思维的健康管理，具有以下特点。

1. 以人为中心 全科医生不仅要关注个体及人群的躯体症状，还须关注其心理状况、社会背景、文化倾向，以及价值观、期望和偏好等，尊重个体及人群的自主权和选择权，并建立互相信任和良好合作的关系。

2. 关注全人 全科医生对个体及人群的评估和干预不是针对单一系统或问题，而是以整体观角度关注其躯体和心理健康状况，以及在家庭和社区中的角色和功能。

3. 提供连续性服务 全科医生在个体及人群的不同生命周期阶段，提供持续的健康管理服务，倡导医防融合。

4. 实施系统性、综合性服务 全科医生根据个体及人群的个体差异和多样化的需求，综合运用多种方法和资源，提供适宜的健康管理方案，包括生活方式干预、心理和社会支持等。

5. 协作与协调 全科医生与专科医生、护士、社工等协作沟通，协调健康管理相关的各方资源，如学校、街道社区、乡镇及社会机构组织等，为居民提供优质、高效的服务。

6. 个性化 全科医生根据个体的具体情况，制订个性化的健康管理计划，将其能力、动机、障碍等因素纳入综合考量，帮助个体设定可实现和可测量的健康目标，并定期评估和调整。

基于全科医学思维的健康管理，有利于提高个体及人群的健康素养和自我管理能力，增强其对自身健康的责任感和主动性，促进其与医生之间的共同决策和良好合作，从而实现个人、家庭和社会层面的健康促进。

（三）健康管理主要内容

健康管理是指通过科学的方法和手段，针对个人或群体的健康状况收集信息、开展评估、进行指导和干预，并动态监测，以期发现健康危险因素，采取有效干预手段，减少疾病发生，从而提高个人或群体的健康水平和生活质量。健康管理主要包括以下主要内容。

1. 收集健康信息 通过询问、体检以及实验室检查等方式，针对个人或群体的健康风险因素、生活方式、心理状态、生理功能等收集信息。

2. 开展健康评估 对健康信息进行全面分析，确定健康状况、健康危险因素或健康问题，以制订个性化的健康管理计划。

3. 实施健康指导和干预 通过健康教育、行为改变、药物治疗、营养调节、运动指导等方式，增强自我管理能力，纠正个人或群体的不良生活习惯、减少或避免健康危险因素的影响，有效改善亚健康状态，提高慢性病的治疗和康复效果。

4. 开展健康监测 通过定期的体检、检测、追踪等方式，对个人或群体的健康状况和健康管理计划的执行情况进行动态观察，及时发现和处理异常情况，调整和优化健康管理计划。

收集健康信息、健康评估、健康指导和干预以及健康监测，是不断循环的、动态的健康管理过程，从而实现对不同年龄阶段、不同健康及疾病状态采取有针对性的连续性的健康管理。

健康管理的关键环节包括：①对个人或群体的健康状况和疾病风险因素进行充分分析与评价，让其能够准确了解自身的健康状况以及潜在的隐患，积极地参与到自身的健康管理中，并且采取相应行动以改善其健康状况。②制订有针对性的健康管理计划，并实行追踪与干预。③通过有计划、有组织、有系统的健康教育和健康促进活动，促使人们能自愿地改变不健康的行为和生活方式。

（四）健康管理意义

健康管理体现出医学模式的转变和医疗服务内涵及功能的不断发展。生物-心理-社会医学模式要求从关注疾病状态前移到关注健康人群、亚健康状态、高风险人群等；从关注疾病的致病因素拓宽到关注可导致疾病产生的社会、环境综合因素以及各种健康相关的危险因素。这意味着医疗服务系统不仅要关注患病人群，更要重视健康危险因素对人群造成的损害，并对健康进行管理。

NOTES

健康管理具有多重意义。

1. 从个人角度　健康管理可以帮助人们了解自己的身体状况，发现潜在的健康风险，及时采取措施改善生活习惯，从而预防或延缓疾病的发生；健康管理可以提供个性化的健康指导和建议，根据每个人的年龄、性别、基因、体质、环境等因素，制订合理的健康目标和计划，帮助人们养成健康的生活方式；健康管理还可以增强人们的健康意识和责任感，让人们认识到健康不仅是个人的权利，也是个人的义务，鼓励人们积极参与健康管理，主动关爱自己和他人的健康。

2. 从社会角度　科学的健康管理可以提升群体健康水平和健康素养，促进医疗资源的合理利用；通过定期的健康检查和评估，及时发现并处理健康问题，减少不必要的医疗费用和医疗负担，降低社会保障的支出，促进社会和谐和稳定，提升国民素质和竞争力。

3. 从经济角度　健康管理可以节省医疗费用，增加劳动生产率，创造更多的经济价值，推动社会经济的发展和进步。

二、健康管理的主要应用场景

1. 在医疗机构中的应用　目前，医疗机构开展健康管理的做法多是通过健康体检收集信息、开展健康评估、实施健康指导和干预、追踪随访等。医生通过收集健康信息，从中发现可能危害健康的不良因素，对个体进行健康分析，从医学和健康管理角度开展生活方式指导，并对重要的危险因素提供干预建议；后续通过建立档案和追踪随访进行持续健康管理。医疗机构开展健康管理有利于完善医疗服务的流程，满足不同人群的健康和疾病管理需求。如针对健康或亚健康人群开展健康教育，提升其自我健康管理能力，纠正其不良生活方式；针对慢性病人群制订减少其健康危险因素的健康促进计划，调动患者的能动性，并连续追踪干预。

需要强调的是，社区卫生服务在我国的医疗卫生体系建设中发挥着重要的作用，全科医生是居民健康的“守门人”。作为健康管理实施的重要载体，社区卫生服务中心如何优化社区卫生资源的分配和利用，有计划和组织地开展科学健康管理是目前研究和关注的重点。不少社区卫生服务中心积极探索新的健康管理方式，如建设健康管理单元、结合家庭医生签约制度开展社区健康管理以及针对特殊人群的跨界、跨学科协作的健康管理服务等。

2. 在企事业单位中的应用　企事业单位开展健康管理可以帮助员工预防和控制职业病和慢性病，降低医疗费用，减少缺勤率，增强员工的身心健康，提高工作满意度，从而提升单位的核心竞争力。企事业单位可以在工作场所创建与健康生活方式相关的良好工作环境，包括在工作场所实施禁烟、提供运动器械或健身房、改善食堂餐饮、聘请心理专业人员进行减压辅导等。企事业单位可以通过自主或服务外包的方式来开展健康管理。企事业单位和一些健康服务单位或独立的健康管理公司签约，健康管理公司设置健康督导专员负责健康跟踪服务，通过电话或在线随访，和客户一起实施保健计划。

3. 在健康保险领域中的应用　健康保险公司可以通过提供健康评估、健康教育、疾病管理、健康咨询等服务，帮助客户了解自己的健康状况，改善不良的生活习惯，预防和控制慢性病，减少医疗费用和医疗风险。健康管理在健康保险领域中的应用，可以用于控制投保人群的健康风险、预测投保人群的健康费用，帮助保险公司降低赔付成本，提高客户满意度和忠诚度，增强市场竞争力。

第二节 | 健康管理的实施策略

一、收集健康信息

通常情况下，居民的健康和疾病信息在卫生服务过程中会被发现和记录，包括各类就诊记录、健康体检和专题健康调查记录等。常见的信息及来源主要包括以下方面。

1. 基本信息 包括性别、年龄、职业、家庭成员情况等一般信息。

2. 儿童保健信息 包括出生医学证明、新生儿疾病筛查记录、儿童健康体检记录以及体弱儿童管理记录等。

3. 妇女保健信息 包括婚前医学检查、妇女健康检查、产前检查记录、分娩记录、产后访视记录、孕产妇高危管理记录等。

4. 疾病控制信息 包括个人预防接种记录、各类传染病报告、职业病报告、农药中毒报告、行为危险因素监测报告和居民死亡医学证明书等。

5. 疾病管理信息 如高血压、糖尿病、肿瘤、精神病等疾病管理随访记录。

6. 医疗服务信息 如门诊病历、住院病历及病案首页、健康体检记录等。

个体或群体的健康信息需要通过一定的渠道，按照一定的程序，采用科学的方法进行有组织、有目的、有计划的采集。除了调取各类健康服务记录，还需要通过以下三种主要方法来获取资料信息。

1. 访谈法 通过谈话了解家庭健康背景、个人生活方式、身心状况以及对健康管理的态度等。常见的访谈法主要有：面对面访谈、电话访谈、个别访谈、集体访谈等。访谈法具有准确且灵活、能进行深层次调查等特点，但也有成本花费高、影响因素多等不足。

2. 问卷法 通过由一系列问题构成的调查表收集资料信息，也称为“书面调查法”或“填表法”，是采用书面的形式进行间接收集所研究材料的一种调查方法。其优点是可以大规模地收集数据，节省时间和成本，也可以保证被调查者的匿名性。缺点是真实性和调查质量不一定能得到保障。

3. 实地观察法 分析人员借用人的感觉器官、观察仪器或计算机辅助系统在现场对观察对象进行直接观察、检查、测量或计数而取得资料。其优点是取得的资料较为真实可靠，缺点是需要花费较多的人力、物力和财力。

二、评估健康危险因素

（一）健康危险因素的含义

健康危险因素是指在机体内外环境中所存在的，与疾病的发生、发展以及死亡相关的诱发因素，即能使疾病或者死亡发生的可能性增加的因素。健康危险因素有些是先天存在的，有些是后天形成的；有些是自然的，有些是人为的；有些是稳定的，有些是变化的。健康危险因素类别多样，其本身性质以及对健康的作用也各有差别。

（二）健康危险因素的类别

1. 生活方式因素 生活方式是个人或群体在一定的历史时期与社会条件下形成的一种行为倾向或行为模式，包括人们的衣、食、住、行、劳动工作、休息娱乐、社会交往、待人接物等物质生活和精神生活的价值观、道德观、审美观，以及与这些方式相关的方面。常见的不良生活方式包括吸烟、缺乏运动、酗酒以及不健康饮食等。

2. 环境因素 环境因素包括自然环境因素和社会环境因素。自然环境包括地理位置、气候条件以及资源状况等。社会环境是指人类生存及活动范围内的社会物质、精神条件的总和，包括政治、经济收入、文化教育、职业、居住条件、家庭关系、心理刺激、工作紧张程度及各类生活事件等。

3. 生物学因素 生物学因素包括病原微生物、遗传、生长发育、衰老等。人体的基本生物学特征是健康的基本决定因素，与环境因素、行为生活方式等综合作用对健康造成影响。

4. 卫生服务因素 卫生服务因素包括对居民所提供的疾病预防、诊断、治疗、护理和康复等服务质量、技术水平及服务的覆盖面；居民所能获得卫生服务的公平性、经济承担程度。

（三）健康危险因素的评估内容

通过对健康信息进行分析来鉴别健康危险因素和判断健康风险的大小，可以帮助人们了解自己的健康状况，并采取相应的措施降低危险因素对健康的危害。

健康危险评估一般分为一般健康状况评估、疾病风险评估、生命质量评估。

NOTES

1. 一般健康状况评估　一般健康状况评估主要是根据健康信息，对身体总体状况、存在的主要问题以及生活方式做出评价，要注重分析生活方式对健康的影响。

2. 疾病风险评估　疾病风险评估能直观地反映个体所存在的患病危险因素，加强警示作用，从而采取针对性措施对疾病做出预防。如，对有咀嚼槟榔习惯的人群，要评估罹患口腔癌的风险。随着医学科技手段的发展，目前疾病风险评估可以根据与疾病相关的危险因素，选取适合的疾病预测模型来进行量化测算。

3. 生命质量评估　生命质量，又称生存质量、生活质量，是人们对于自己身体状态、心理功能、社会能力以及个人整体情形的一种感觉体验，常用的评估量表包括国家标准生活质量测定量表，健康调查量表以及各种特殊行为功能量表；内容包括躯体健康、心理健康、社会功能、疾病状况和对健康的总体感受等。这种评估多以社会经济、文化背景和价值取向为基础，因此生命质量评估的目的是比较个体或人群健康状况及变化，评价疾病带来的负担和对生活质量造成的影响，并进行临床和经济学评价，为卫生政策制定和卫生资源的合理利用提供依据。

（四）健康危险因素的评估方式

健康危险因素的评估主要包括三个基本方式：问卷调查、风险计算和评估报告。

1. 问卷调查　问卷调查是人们通过收集信息而进行健康风险评估的一个重要工具。根据评估的重点与目的不同，所需的信息会有所差别。常见的问卷调查信息包括：生理和生化数据、生活方式、个人或家族健康史、自然和社会环境因素、健康相关态度和知识方面的信息等。问卷在内容设置上要求与调查主题紧密相关，问题设置具备逻辑性、规范性和非诱导性，还要注意问卷调查的实际可操作性，尽量保证采集信息的真实有效。

2. 风险计算　健康风险计算主要以疾病为基础对危险因素进行评价，是研究危险因素和疾病发病率以及死亡率之间数量依存关系和规律的一种技术方法。目前常用的有单因素加权法和多因素模型法。①单因素加权法建立在评估单一的健康危险因素和发病率的基础上，用相对危险度来表示这些单一因素与疾病的关联强度，得出的各种相关因素的加权分数即为患病的危险性。单因素加权法特点是方法较为简单实用，不需要对大量的数据进行分析，是健康管理在早期发展中就应用的主要健康风险评价方法。②多因素模型法是建立在多因素数理分析的基础上，即采用统计学概率论的方法来得出疾病与危险因素之间的关系模型。多因素模型法特点是包括更多的危险因素，提高了评价的准确性。

采用风险计算评价健康危险因素，常用的有如下几种方法。

（1）绝对危险性（发病率）：绝对危险性是以发病率的方式来表示未来若干年内发生某种疾病的可能性。

（2）相对危险性（风险等级）：相对危险性是相对于一般人群危险度的增加量。如果把一般人群的相对危险性定成 1，被评估个体的相对危险性就是大于 1 或小于 1 的值。

（3）人群 10 年死亡概率：将年死亡率转换为 1 年死亡概率，再根据寿命比的方法将 1 年死亡概率转换为 10 年死亡概率。

（4）健康年龄：健康年龄是指具有相同评估总分值的男性或女性人群的平均年龄，也是健康风险评估中常用的一个结果表述指标。其反映了由于受到生活方式和其他危险因素的影响，被评估对象的健康状况和实际年龄的偏离程度。

（5）可达到年龄：可达到年龄是根据存在的危险因素，提出可降低危险因素的措施，进而计算得到的新评价年龄。

3. 评估报告　通过健康风险评估可以获得包括个人健康信息汇总、生活方式评估、慢性病风险评估、健康改善指导等健康评估报告。这些报告主要用于帮助被评估者系统地了解潜在的健康风险、未来 5 到 10 年发生慢性疾病的概率。基于这些信息，可以开展有针对性的自我健康管理，或通过专业的健康管理服务机构进行专项的健康管理，通过早发现、早预防，控制各类疾病危险因素，以降低疾

病风险和维护健康。

三、健康指导及健康危险因素干预

健康指导是指根据个体或群体的健康需求，有针对性地指导个人或群体掌握卫生保健知识，实行有利于健康的生活方式。健康指导的形式有面对面、电话、网络、移动应用等。健康指导的效果取决于指导者的专业水平、指导对象的参与度、指导过程的质量和持续性等因素。

健康危险因素干预是指通过改变个人或群体的健康危险因素，来预防或减少疾病的发生和发展。健康危险因素干预的目的是提高人们的健康水平和生活质量，降低医疗费用和社会负担。健康危险因素干预的方法有多种，可以分为个体干预和群体干预。个体干预是针对具有某种或某些健康危险因素的个人，通过健康教育、咨询、指导、监测等方式，帮助他们改善不良的生活习惯，增强自我保健能力，减少或消除健康风险因素。群体干预是针对具有共同的健康危险因素的人群，通过制定和实施相关的政策、法规、标准、规范等方式，改善社会和环境条件，促进人们形成健康的生活方式，提高整体的健康水平。

健康危险因素干预的效果取决于多方面的因素，如干预的内容、方式、时间、频率、强度、持续性等。一般来说，越早进行干预，越能有效地阻断或延缓疾病的发生和发展。同时，干预也需要根据不同的对象、场合和需求，采用适合的方法和策略，以提高干预的针对性和可行性。此外，干预还需要有良好的监测和评估机制，以及及时的反馈和调整机制，以保证干预的质量和效果。

健康指导和健康危险因素干预虽然各有重点和侧重方式，但两者之间并非割裂，而是从不同角度实施健康管理举措。积极开展健康指导，能够增强干预效果；两者往往同时进行，共同实施。

常见的健康指导和健康危险因素干预包含以下几方面状况。

1. 减少或停止使用烟草 烟草中含有较多致癌物质，烟雾对呼吸道、心血管、胃肠道等各脏器都可造成不同程度损害。烟草使用是导致癌症、心血管病、肺部疾病及糖尿病等全球非传染病疾病流行的主要危险因素之一，烟草依赖本身也是一种慢性疾病。目前常用“5R”法增强吸烟者的戒烟动机，包括相关（relevance）、风险（risk）、益处（reward）、障碍（roadblock）、重复（repetition）。用“5A”法帮助吸烟者戒烟，包括询问（ask）、建议（advice）、评估（assess）、帮助（assist）和安排随访（arrange follow-up）。

2. 控制过量饮酒 酒精可导致躯体、心理和社会多层面损害，如癫痫、肝硬化、人格改变、交通事故等。饮酒的时间以及量达到了一定的程度，饮酒者对自己的饮酒行为无法控制，并且出现了躯体化和戒断的症状，即酒精依赖。健康管理对酗酒者的指导和干预重点包括改变酗酒者的动机，了解酗酒的危害，以减少其饮酒量。

3. 提供心理支持 心理健康是一个人的生理、心理与社会相互协调的和谐状态，包括智力正常、情绪稳定和愉快、良好的人际关系和适应能力。常见的心理问题可包括严重情绪失控、焦虑、抑郁、恐惧、强迫症、疑病等。常用的心理支持指导和心理干预方法是心理咨询，这是心理咨询师为达到预定目标所采取的一种特殊的交流方式，通过言语和非言语的形式，如共情、倾听、提问、表达等进行心理干预。对属于临床诊疗范畴的心理问题，要有效识别并及时转诊至专业精神卫生机构。

4. 纠正不健康饮食 不健康饮食是常见的健康危险因素：食品过度精细化、饮食种类不均衡、烹制方式过多追求味觉的满足而导致营养成分流失甚至产生有害物质，以及食品加工、运输、烹饪等食品安全问题等。健康饮食指导包括膳食的平衡、对保健食品选用的甄别以及食品安全问题。膳食的平衡意味着要摄入适量的各种营养素，如碳水化合物、蛋白质、脂肪、维生素和矿物质，以满足身体的需要。对保健食品选用的甄别要根据自己的身体状况和需求，选择合适的保健食品，并注意鉴别真伪，避免过量或不必要的摄入。食品安全问题意味着要注意食品的来源、加工、储存和烹饪方式，避免食品受到污染或变质，造成食物中毒或其他疾病。

5. 科学运动 缺乏必要运动和盲目甚至过度运动，是目前比较常见的现象，需要进行指导。身

体活动是指由骨骼肌收缩所致的机体能量消耗增加的活动，如日常生活中的步行、骑车、劳动、上下楼梯、跳舞、游泳、球类运动等。身体活动按照生理功能分类可分为有氧运动、无氧运动和灵活性及柔韧性锻炼。个体身体活动干预包括在干预计划中制订运动目标、运动计划、运动内容和运动进度，并在执行过程中给予督促和指导。对人群的身体活动指导，应根据其所处的不同生理阶段，以及运动耐受力的不同，选择不同的运动方式和强度。

四、健康监测

健康监测是指通过定期的体检、检测、追踪等方式，对个人或群体的健康状况和健康管理计划的执行情况进行动态观察，及时发现和处理异常情况，调整和优化健康管理计划。

健康监测是健康管理的重要组成部分，与收集健康信息、评估健康危险因素、健康指导及健康危险因素干预环节共同组成健康管理动态循环的过程。在对个体或人群的健康监测方面也须注意不同年龄阶段、不同健康状态等差异性，以采取针对性的监测和干预措施。

健康监测不仅要关注身体状态和生活方式，同时还要鼓励居民提升健康素养，对自身健康进行长期连续的动态监测，主动发现问题，及时对疾病作出预防和干预措施。健康管理的相关技术发展和智能产品研发，如通过穿戴式设备记录健康数据、应用远程医疗提供健康服务等，有利于开展健康监测。

第三节 | 亚健康状态管理及重点人群的健康管理

一、亚健康状态管理

亚健康，指处于健康和疾病之间的一种状态，也被称为次优健康状态（suboptimal health status，SHS），包括持续 3 个月以上的慢性疲劳、生理功能减退（如心血管系统、消化系统、免疫系统和神经精神系统等），以及对外界的适应能力下降。亚健康状态常表现为身体不适、精神状态不佳、免疫力下降等症状，但尚未达到严重的疾病状态。亚健康状态常受多种因素的综合影响，如生活方式不良、工作压力大、营养失衡、缺乏锻炼等。亚健康的预后大多良好，及时给予适当的干预，一般可恢复正常，回归到健康状态。但是如果不能科学有效地进行健康管理，一直任由亚健康状态长期发展下去，就会演变成疾病，甚至带来难以逆转的伤害。

针对亚健康状态，健康管理尤为重要，旨在通过调整生活方式、有效管理压力、评估和分析健康状况、社会支持和医学专业指导等措施来改善身体和心理状况，从而避免进一步恶化成为临床疾病。有关亚健康状态的健康管理建议如下。

（1）培养良好的生活方式：采用均衡的饮食，增加蔬菜、水果、全谷物和蛋白质的摄入，限制高糖、高盐和高脂食物的摄入；适度运动，如跑步、散步、游泳、球类等有氧运动，帮助提高心肺功能、增加代谢率和改善体脂肪分布；戒烟和限制饮酒；建立规律的作息时间，优化睡眠环境，这有助于恢复身体功能。

（2）压力管理：学会有效的应对压力的方法，如冥想、深呼吸、放松技巧等，减轻焦虑和紧张情绪；与亲友保持一定联系，必要时交流自己的困惑；积极参与社交活动，能够感受到社会支持，有助于纾解心理压力。

（3）定期体检：定期进行健康检查，了解自身健康状况，及早发现潜在的健康问题；根据自身情况，制订明确的健康目标和计划。

（4）寻求心理健康支持：如存在心理压力大、睡眠障碍、经常焦虑、长期心情低落等问题，要及时寻求心理健康专业人员的帮助。

（5）获得专业指导：对亚健康状态，无须讳疾忌医或逃避，要积极咨询医疗专业人员，如医生、营养师、心理咨询师等，获取专业的健康管理建议和指导。

NOTES

二、重点人群健康管理

重点人群健康管理是为特定人群，如儿童、老年人、孕产妇、残障人群等，制订有针对性的健康管理计划。这些人群的生理和心理特点不同，健康需求有其特点，因此健康管理需要综合考虑身体、心理和社会因素，体现个性化。

1. 儿童健康管理

（1）注意保证充足的营养摄入，尤其是蛋白质、维生素和矿物质。鼓励适量的体育锻炼，促进骨骼和肌肉发育。

（2）确保充足的睡眠时间，有助于生长和认知发展。

（3）避免长时间使用电子设备，保护眼睛健康。

2. 老年人健康管理

（1）保持适度的身体活动，一定程度的有氧运动和力量训练有助于保持肌肉质量和心肺功能。

（2）均衡饮食，摄入足够的蛋白质、钙和维生素 D，维护骨骼健康。

（3）定期进行健康检查，如监测血压、血糖、胆固醇等健康指标。

（4）确保充足的社交互动，预防孤独和情绪问题。

3. 孕产妇健康管理

（1）均衡饮食，摄入足够的营养，特别是叶酸、铁和蛋白质。

（2）适度的孕期体育锻炼，如散步，有助于缓解不适和维持健康。

（3）定期产前检查，确保母婴的健康状况。

（4）孕期情绪管理，减轻焦虑和压力。

4. 残障人群健康管理

（1）适当的康复训练，恢复功能和提高生活质量。

（2）确保医疗设备和辅助工具的适当使用。

（3）提供社会支持和融入机会，避免社会孤立。

5. 免疫系统受损人群健康管理

（1）遵循医生的建议，接受免疫系统支持治疗。

（2）避免接触可能导致感染的环境，保持个人卫生。

（3）注意预防传染病，接种合适的疫苗，避免交叉感染。

6. 职业暴露人群健康管理

（1）采取适当的防护措施，减少职业暴露对健康的影响。

（2）定期体检，监测可能受到影响的健康指标。

（3）学习正确的职业健康保护知识，预防职业病。

7. 跨国移民人群健康管理

（1）适应新的生活环境，寻求社会支持和社交互动。

（2）确保接受当地医疗服务，了解当地医疗制度和保险政策。

（3）维持原有的健康管理计划，尤其是慢性疾病患者。

第四节 | 健康管理中的主动健康观念与行为

主动健康是一种基于整体医学观和生物-心理-社会的医学模式，通过政府、社会、家庭及个体的协同作用，发挥人的主观能动性，构建积极的健康素养体系和行为方式的健康观念。

主动健康管理强调个体的主观能动性，增强主动获得持续健康的能力，拥有健康的生活品质和良好的社会适应能力。主动健康理念倡导对健康进行长期连续的动态监测，强调主动发现、科学评估和

积极调整。主动健康的目标是让个体主动学习健康知识和技能并养成健康习惯，通过预防、监测及干预减少疾病的发生，提高全民的健康水平。

主动健康管理与传统医疗模式的不同在于：①个体主动参与：医疗过程通常由医生决定治疗方案；而主动健康管理强调每个人是自己的健康第一责任人，应参与对自身的健康决策，对自身健康进行主动管理。②预防优于治疗：与通过药物和手术对已经出现的疾病进行治疗相比较，主动健康管理强调通过实施预防措施来避免疾病的发生。③综合健康管理：医疗行为以疾病为中心，而主动健康管理的理念和行为则以人为中心，关注个体的全面健康，包括生理健康、心理健康和社会适应能力。④科技和大数据的应用：主动健康管理模式强调借助先进的科学技术，对个体的健康信息进行连续动态监测，进行精确的健康评估和个性化的健康管理。

因此，主动健康管理是一种更加积极、全面和科学的健康管理理念，也是对传统医疗模式的重要补充和发展。

一、主动健康的内涵

主动健康的内涵包括主观能动性、可及性、智能化、协调融合性四个方面，以政府为主导，以现代科技为媒介，充分发挥社会和个人的主观能动性，通过在各层次实施主动健康策略，提高全民健康水平。

1. 主观能动性　主动健康的主观能动性主要体现在个体维护健康的主动性和积极性，主动地掌握维护健康的知识与技能，选择符合自身特点与家庭特色的健康生活方式，识别疾病危险因素并及时作出适当的决策，以及自觉利用科技手段监控自我健康状态等方面。个体作为主动健康管理的实施主体和受益方，应明确自己是自身健康的第一责任人，主动参与健康决策，自觉养成健康行为，在不同生命周期采取相应的健康干预措施，通过去除危险因素降低患病的风险，降低未来可能的治疗成本，以提高生活质量。

2. 可及性　可及性是指各种机构及资源向目标人群开放并满足其需要的能力，即卫生服务和健康资源的可获取性、地理可达性和经济可负担性，主动健康倡导通过提高健康资源和健康服务的可及性，使每个人都能够获得全面、公平、合格和高效的卫生服务。

主动健康的可及性包括卫生服务的可及性和健康信息的可及性两个方面。卫生服务的可及性主要通过医疗机构实施主动健康管理，建立区域分级诊疗模式，实现优势医疗资源下沉，保证公共卫生服务的可及性和均等性；通过家庭医生签约服务，构建多种形态的主动健康管理项目，提供个性化医疗服务。健康信息的可及性则是通过现代信息技术搭建信息平台，整合健康资源，提高健康信息的真实性、完整性和权威性，借助知识讲座或新媒体等多种方式积极宣传健康的生活理念，提升居民健康素养，促进居民健康行为习惯的养成。

3. 智能化　在实施主动健康管理的过程中，智能技术和产品的开发和应用是其中重要的推动因素。大数据能够进行风险评估和疾病预警；穿戴式设备和移动应用能够进行个体健康行为的连续动态跟踪、收集和健康数据分析；人工智能技术能够在健康咨询中提供帮助；远程医疗技术能够更加便捷地提供医疗服务等。这些智能技术和产品能够深度分析健康数据，有效地提高预防和治疗的精确性及服务的便捷性，为个体提供精准的健康评估和个性化的健康计划。主动健康管理需要依靠不断发展的智能化设备和信息技术，开展健康监测、健康评估、健康干预等，以提升主动健康管理的水平。

4. 协调融合性　主动健康的协调融合性强调各种健康资源的相互配套和支持。实施主动健康管理需要全社会各部门的协调推进以及卫生健康系统相关机构的资源统筹，以实现对健康服务的全面融合。如，优化环境保护，强化公共卫生体系建设，促进各级健康机构整合医疗、预防、康复等各类健康服务，探索并实现常规医学与运动医学的融合、西医和中医结合的健康服务模式等。

综上，主观能动性、可及性、智能化和协调融合性四个方面构成了主动健康的核心内涵。在此范

畴中，相关主体不仅需要关注疾病的诊疗，更要注重疾病预防和健康促进，倡导个体、社区和全社会的共同参与，同时利用现代科技手段进行精准的健康管理，实现健康服务的全面覆盖和个性化提供。通过实施主动健康管理，可以达到更为有效和全面的健康管理。

二、开展主动健康管理的意义

实施主动健康管理具有深远的现实意义，可影响微观的个体健康状态和宏观的社会健康水平。主动健康管理的开展对于增强公众健康意识、提高人民健康水平、推动医疗技术创新、改变医疗保健模式、推进健康中国建设都具有重要作用。

1. 增强个人的健康意识和行为 主动健康管理模式鼓励个人积极参与自身的健康管理，为自身的健康负责，倡导健康的生活方式，提高个人健康素养，从而增强个人的健康意识和行为。

2. 开展疾病预防和早期干预 主动健康管理强调对个体健康状况进行持续、系统的监测和评估，对存在的健康问题进行及时干预，不仅可以提高治疗的有效性，还有助于降低长期的医疗费用。

3. 推动医疗技术和服务创新 实现主动健康管理的目标需要借助大数据、人工智能、可穿戴设备等前沿技术，推动医疗技术的创新。同时，主动健康也倡导个性化、精细化的医疗服务，提高医疗服务的满意度和效率。

4. 改变医疗保健模式 主动健康管理模式强调预防优于治疗，将重心从传统的疾病治疗转向预防疾病和维护健康，这是医疗保健模式的重大转变。

5. 推进健康中国建设 主动健康理念鼓励社区和公众参与健康管理，改善公共卫生状况，提高社区整体的健康水平。通过主动健康的推进，个体的健康意识将会得到增强，健康水平将会得到提升，进而降低社会医疗资源的压力，对实现“预防为主、人人参与”的健康中国战略目标具有积极作用。

三、主动健康管理相关主体的职责及工作策略

主动健康管理是以公众多元健康需求为导向，是促进全民健康的重要实践探索，其关键在于从供给侧和需求侧两端共同发力。

实施主动健康管理，需要多主体（政府及有关部门、医疗机构、社区、社会组织以及家庭等）协同推进，承担相关职责，实施相关的主动健康管理策略，共同构成完整的主动健康管理系统。

（一）政府职责及工作策略

政府部门应承担起积极引导健康促进和统筹资源的责任，制定政策和法规，提供资金和资源支持，有效动员和赋权社会和个体参与，并在实践过程中实现协作配合和整体联动，开展多方位、多层次的合作，建立主动健康管理的公共服务体系，打造一个包括医疗、医保、教育、农业、自然资源、工业在内的社会健康生态系统。

1. 制定政策 政府应通过立法和政策制定来推动主动健康管理，如预防疾病、发展公共健康和健康教育相关政策等，以鼓励和引导各主体形成主动健康管理行为并限制不良健康行为。通过制定和执行健康相关法律、标准及规范，明确各主体责任，保护公民健康权利，维护大众健康，为主动健康管理提供制度保障。

2. 提供资源支持 投入资金和人力资源来支持主动健康管理，使公共健康基础设施、医疗服务、健康教育等方面的指导政策与资源配套。

3. 强化健康教育 通过公众教育、学校教育、媒体宣传等方式增加公众的健康知识和技能，增强健康意识，鼓励健康行为。

4. 开发维护或促进健康的科学技术 如推动电子健康记录、远程医疗、健康应用等技术的使用，以提高健康服务的效率和效果。如开发应用穿戴式设备和移动应用实时监测个人的健康数据（如心率、血压、运动量、饮食、睡眠等），并提供个性化的健康建议和提醒；应用远程医疗为患者提供咨询、诊断和治疗服务，提高了医疗服务的便利性和可及性；应用电子健康记录系统可以帮助医生和患者有效

NOTES

管理健康信息；人工智能通过分析健康数据可以预测疾病风险、发现健康趋势、优化健康策略；人工智能还可以辅助医生进行诊断和治疗，提高医疗的精度和效率。

5. 推动社区参与　通过社区健康项目、志愿服务等方式鼓励社区组织和个人参与健康管理。

6. 建立监测和评估系统　通过对公众健康状况、健康服务的使用情况、健康行为等进行持续的监测和评估，了解主动健康管理的实施情况，并为政策决策提供数据支持。

这些策略需要政府在制度设计、资源分配、公众教育等方面发挥主导作用，以推动主动健康管理系统的建立和发展。同时，政府也需要与医疗机构、社区、学校等各方协同合作，共同促进主动健康管理的实施。

（二）医疗机构的职责及工作策略

医疗机构提供基于医防融合的综合性健康服务，建立以健康为中心、跨学科的健康服务系统。

1. 提供疾病预防服务　医疗机构提供预防性的医疗服务，包括健康检查、疫苗接种、疾病筛查等。预防性服务能提前发现和处理健康问题，避免疾病的发展和恶化。

2. 开展健康教育　医疗机构可以通过公众教育、媒体宣传、健康课程等健康教育活动，以及咨询服务等方式提供健康知识，帮助患者了解疾病预防和健康管理的重要性，提高个人的健康素养，使其具备自我管理健康的知识和技能。

3. 使用健康技术　医疗机构可以使用电子健康记录、远程医疗、移动健康应用等技术，提高健康服务的效率和效果，为健康决策提供数据支持。

4. 推动多部门合作　医疗机构可以与政府、社区、学校、企业等其他部门合作，开展社区健康项目，共同促进主动健康管理的实施。

5. 加强科学研究　深入研究主动健康管理的理论基础，包括内涵特征、实施方案、评价体系、测评工具、影响因素等。通过实证研究确定干预措施、评价干预效果，探索最优的实施方案。

各级医疗机构作为服务提供的主体，贯穿于主动健康管理实施的全过程，需要医疗机构及医务人员在服务提供、技术应用、多部门合作等方面发挥主导作用，以推动主动健康管理的实施。

基层卫生机构以及全科医生作为实施主动健康管理的主力军，扮演着医疗服务提供者、健康管理者、健康教育者、健康倡导者、资源协调者等多重角色，在健康教育及管理、疾病预防和干预、社区健康推广、卫生及社会资源的协调和现代信息技术的应用等方面都发挥着更重要的作用。全科医生不仅关注个体健康，也要关注社区范围的公共健康问题。通过参与社区健康活动的策划和实施，推广健康生活方式，预防和控制传染病，参与社区健康计划的制订和实施，鼓励社区成员参与健康促进活动，提高社区整体健康水平。

（三）社区的职责及工作策略

社区作为各项公共卫生政策、健康促进项目的落脚点，可以通过组织健康活动，提供健康教育和服务，建立支持健康的环境的方式来实施主动健康管理。

1. 健康教育　社区可以通过举办健康讲座、分发健康教育材料、组织健康活动等方式，加大主动健康理念的宣传，倡导居民成为健康的“第一责任人”，增加居民的健康知识和技能，鼓励健康的生活方式。

2. 提供健康服务　社区可以提供或协助提供连续性的健康服务，如健康检查、疾病筛查、疫苗接种、健康咨询、设立健康小屋等。

3. 建立健康环境　社区可通过提供运动设施、推广健康饮食、控制环境污染、减少安全风险等方式营造支持健康的环境。

4. 推动居民参与　社区可以通过组织社区健康项目、志愿服务的方式鼓励居民参与健康管理，让居民在健康教育、健康活动、健康服务等方面发挥作用。

5. 协同合作　社区可以根据区域居民的健康需求，与政府、医疗机构、社会组织等合作，引进健康管理资源，开展不同方式的健康促进活动。

通过实施这些策略，社区可以在生活圈内推动主动健康管理，帮助居民了解并采取健康行为，预

防疾病的发生，提高生活质量。

（四）社会组织的职责及工作策略

社会组织，如企事业单位和学校，在推进主动健康策略方面，需要发挥更积极的作用。

以学校为例，要教育学生了解健康知识和技能，尽量提供健康的学习环境，与家庭和社区合作推动学生健康，从而实施主动健康管理。

1. 健康教育 学校通过课程和活动向学生传授关于营养、运动、个人卫生、精神健康等方面的知识，培养他们的健康习惯和生活方式。健康教育应纳入常规课程，以确保学生接受此类教育。

2. 提供健康的学习环境 学校应提供一个促进学生身心健康的环境，包括安全的设施、适当的体育活动、营养餐饮等。

3. 定期实施健康检查 定期对学生进行视力、听力、身体发育等方面的健康检查，及早发现和处理健康问题。

4. 提供心理健康支持 提供心理咨询服务，帮助学生应对学习压力，提高社会适应能力，促进他们的心理健康。

5. 开展家庭和社区的合作 学校与家庭合作共同促进学生的健康，通过与家长共享学生的健康信息、向家长提供健康教育的方式，鼓励家庭养成健康的生活方式。学校也可以通过与社区的医疗机构、社区组织合作，提供更广泛的健康服务和资源。

通过这些策略，学校可以帮助学生形成健康的行为和生活方式，预防疾病的发生，提高学生的学习和生活质量，提高健康水平。

（五）家庭的职责及健康策略

家庭是实施主动健康管理的基本单位，也是重要的健康管理实施场所。家庭成员间互相鼓励、互相监督，能够营造富有家庭特色的健康促进氛围。

1. 建立健康的生活习惯 家庭成员应该一起建立和维护健康的生活习惯，如均衡饮食、定期运动、保证足够的睡眠、避免烟草和过量饮酒等。

2. 共同学习健康知识和技能 家庭成员应学习和理解疾病预防、健康饮食、运动等方面的健康知识，在日常生活中作出正确的健康选择。

3. 定期健康检查 家庭成员应互相督促，定期进行健康检查并根据需要随访，这有助于及时发现并处理可能的健康问题。

4. 关注心理健康 家庭成员之间应关注心理健康，提供精神支持，鼓励开展压力管理活动并在需要时寻求专业帮助。

5. 利用技术提高健康管理 现代技术（如健康应用程序、健康追踪器等）可以帮助家庭成员管理健康，监控日常活动，提供营养建议，记录健康数据等。

6. 家庭应急处理 家庭成员应学习和掌握基本的急救技巧，以便在家庭突发事故时进行及时的初步处理。

通过实施这些策略，家庭可以成为主动健康的重要基础，预防疾病的发生，帮助家庭成员维护和提高健康水平。

（六）个人的职责及健康策略

个人可以通过保持健康生活习惯，定期进行健康检查，保持心理健康，学习和理解健康知识，使用技术助力，提高健康素养来实施主动健康。

1. 建立并保持健康的生活习惯 积极参加锻炼，保持均衡的饮食，适当休息和睡眠，避免烟草和过量饮酒。

2. 进行定期健康检查 定期进行全面的健康检查，以及针对家庭和个人风险因素的专门检查，早期发现并处理可能的健康问题。

3. 保持心理健康 注意自己的精神健康，了解压力管理技巧，如冥想、深呼吸和瑜伽等，并在需

NOTES

要时寻求心理咨询或治疗。

4. 提高健康素养　通过读书、在线课程、参加健康讲座等方式，增加健康知识，以便在日常生活中作出正确决策。掌握基本的自我保健技能以维护和促进健康水平。

5. 学习健康相关信息技术　利用可穿戴设备、移动医疗终端、健康小屋等现代技术来监控、管理自身的疾病管理情况和提高健康水平。

6. 参与社区健康活动　参加社区、学校或工作场所的健康促进活动，如健康教育、健身课程、健康检查，了解健康的重要性、疾病预防知识、健康生活方式。

7. 激发主观能动性　通过明确健康责任、建立健康信念、设定健康目标、制订和实施健康行为计划、寻求亲友健康小组的社交支持等方式提高个人追求健康的主动性。

通过实施这些策略，个人可以更好地管理和提高自己的健康水平，预防疾病的发生，提高生活质量。

第五节 | 全科医生与健康管理

开展健康管理是全科医生的重要工作职能和岗位职责。当前全科医生在社区慢性病管理、家庭医生签约中发挥着健康管理的作用，是健康管理服务的主要实施者。全科医生要建立“医防融合”工作理念，对个体或群体的健康状况、生活方式、心理状态等进行全方位的综合评估和干预，以做到早发现早治疗，预防疾病的发生和发展，提高居民的生活质量和健康水平。全科医生应该具备健康管理的基本知识和技能，熟悉健康管理的实施策略和方法，能够为居民制订合理的健康管理计划，指导居民进行自我管理，并协调多部门多学科的健康资源，实现全人、全程、连续的健康服务。

（一）基于家庭医生签约服务的居民健康管理

全科医生通过家庭医生签约服务，能更好地与居民建立长期稳定的合作关系，增强居民的健康意识和自我管理能力，促进居民的健康行为和生活方式的改善。通过以家庭为单位的管理，建立家庭健康档案，评估家庭整体和成员的健康状况及危险因素，提高健康管理中的家庭效能。如基层卫生机构及全科医生可根据居民具体的健康管理需求开发不同的个体化服务包，包括健康评估、双向转诊、规范化治疗、定期检查随访、用药指导、个性化健康教育等；还可以结合家庭医生预约上门和家庭病床更好地为居民开展健康服务。

（二）以全科团队为主导的社区慢性病患者的健康管理

由全科医生主导的全科团队成员包括全科医生、护师、健康管理师、营养师、康复师、心理咨询师以及其他预防保健人员。全科团队通过综合评估患者的整体健康状况，为其制订个性化的疾病防治计划，并协调各类医疗和社会资源对患者的疾病危险因素作出持续的干预和督促，以改善患者的疾病预后和提高生活质量。全科团队在对慢性病的管理中，可以通过慢性病小组互助、传播健康知识理念等方式来提高患者及家庭成员对疾病的认识和自我管理能力，并做好其健康档案的管理，以便于后续的评估和服务预约。

（三）社区健康管理资源的优化整合

全科医生可以通过参加全科专病管理门诊、家庭医生签约工作室、体检中心、慢性病筛查工作站及健康小屋等方式深入参与社区健康管理；与二、三级医院、疾控机构、学校或协会开展健康管理合作，如健康科普、健康促进项目、慢性病筛查项目、专病管理及多学科联合门诊等。

第六节 | 健康管理面临的挑战及发展前景

一、健康管理面临的挑战

当前健康管理服务和产业也面临着不少问题和挑战，包括健康管理环节和供需协同方面的欠缺，

以及科学技术发展和市场飞速增长带来的安全和监管等问题，健康管理人才的培养和储备所存在的缺口问题等。

（一）健康管理主要环节需要完善和优化

1. 健康信息采集 目前存在的常见问题是健康数据质量参差不齐，信息的完整性和准确性也有待提升。以作为健康大数据重要来源的电子健康档案为例，存在着多部门管理而重要数据不能共享的健康及疾病信息分割问题，不同的数据系统之间存在壁垒，无法实现数据的联通共享；存在着部分数据缺失、信息登记错误和数据异构等信息质量问题。这些问题都会影响健康信息的有效采集以及后续健康风险评估和干预。

2. 健康风险评估 健康风险评估所需的科学有效工具或模型尚有待完善。国内健康管理学科发展的时间仍较短，适用于群体或特殊人群的健康评估风险因素涵盖面比较窄，容易忽略其中的行为、心理和环境因素影响。此外，健康风险评估工具也需要注意避免滥用，如评估误差的忽略和结果的过度解读等。

3. 健康干预 健康干预存在的问题主要是持续性和有效性难以保障。当前居民对健康管理重要性和方法方面的认知还存在较大不足，并且普通人由于长期养成的自身生活和行为习惯，很难做到并坚持摒弃不良影响因素。当前用于监测健康干预过程与效果的方式主要包括邮件、短信、电话、移动程序等，也较难形成正向反馈激励，导致其成效不足。

（二）健康管理的供需双方需要加强协同

1. 供方 随着健康管理市场呈现出快速增长的态势，各类提供健康管理的机构和部门不断涌现，如健康体检中心、健康管理咨询公司、互联网医疗平台等。但整个健康管理服务产业尚缺乏行业标准化建设，所提供的服务质量参差不齐。值得注意的是，当前健康管理服务机构在相关资源配置和运营机制上也存在欠缺。以作为健康管理服务主要阵地的社区卫生服务中心为例，目前存在问题包括：开展健康管理服务的健康管理师、全科医生等人员数量不足；疾病预防和治疗之间的协同性欠缺，医防融合不足，普遍对“治”的重视大于“防”；健康管理服务收费未纳入医保目录，难以体现供方服务价值并建立良好激励机制。

2. 需方 居民当前未能很好建立“自己是自身健康第一责任人”的理念，相对于疾病治疗的刚需，健康管理是“软需求”，且见效慢，导致居民健康管理的参与度和配合度都较低。

（三）技术发展带来的新问题

随着信息技术、生物技术、医疗器械等领域的快速发展，健康管理有了更多的工具和手段，如大数据分析、人工智能、远程医疗、可穿戴设备等。这些技术在提高健康管理效率和精准度的同时也带来了数据安全、伦理道德、法律法规等方面的新问题和挑战，值得引起重视。

（四）市场监管难度

随着健康管理市场的快速增长，不断涌现的各类健康管理机构和服务，如健康体检中心、健康管理咨询公司、互联网医疗平台等，为消费者提供更多选择和便利的同时，也为健康管理市场的监管加大了难度。

（五）健康管理人才队伍建设存在短板

健康管理是一门综合性、跨学科的学科，需要具备医学、管理、统计、心理等多方面的知识和技能。目前，我国在健康管理人才培养方面还存在较多问题，如教育体系不完善、课程设置不合理、师资力量不足等，需要加强健康管理专业的建设和发展。

二、健康管理发展前景

随着国家对健康事业的重视和投入，健康管理也得到了更多的政策支持和资源保障，如《“健康中国 2030”规划纲要》《国务院关于实施健康中国行动的意见》《国家基本公共卫生服务规范》等文件的出台，为健康管理提供了指导和实施依据。健康管理在资源整合、技术发展和社区建设方面都有

NOTES

着更多的发展前景。

（一）健康管理资源的优化整合

随着卫生工作观念从“以治病为中心”向“以健康为中心”转变，健康管理服务需要整合医疗以外的更多资源，如在社区中实施“医防管”融合的一体化健康服务，以实现服务流程、生命周期、供需协同多个闭环。其中，服务流程闭环涵盖健康信息采集、健康评估、健康干预、干预后效果跟踪评价；生命周期闭环包含生老病死的全程管理；供需协同闭环包括作为健康管理提供者的医生、健康管理师、卫生管理者，以及作为健康管理受众的健康、亚健康、慢性病等各类人群。另外，健康管理资源的优化还包括管理、组织、服务、运营等层面的设计，在各级医疗和保健部门之间建立协作和互动。

要重视各方采集的健康信息的整合以及一定程度上的标准统一化，打破部门间的信息壁垒，使个体及群体的信息能够实现一定规则下的联通共享。

（二）科学技术不断发展

健康管理的实施需要科技手段作为支撑，不仅包括健康评估中的检测手段、评估工具的优化，还涉及健康管理的信息化系统建设，如推广应用大数据、人工智能、区块链、物联网等新兴技术，实现健康数据互联互通，打造社区数字化、智能化健康管理功能平台，实现健康数据的整合共享。信息系统的互通有利于对当前不同系统中不同区域、人群、健康数据的高效整合和利用。

（三）社区健康管理建设

社区作为健康管理服务的主要阵地，其健康管理的建设有着更多发展前景。当前社区已经循序渐进开展各类健康管理服务，如通过组建全科医生团队加强对慢性病患者评估和干预的监测；以家庭医生签约服务为抓手，协调分级诊疗的卫生资源，为家庭成员提供全方位的医疗照护及全程的健康管理；建设高质量的社区健康管理中心；打造医生和居民共同参与的共享式、预约化、标准化的健康管理门诊；打造兼具“科技+人文”显示度的健康管理服务场景等。

当前健康管理的发展仍面临各项挑战，社会各界需要重视和强化健康管理学科的建设与发展，支持与鼓励健康管理技术的研究，打造政府、社会、市场参与，满足居民多样化、个性化健康管理需求，协同供方、需方和支付方的健康管理服务产业生态，以推动我国健康管理服务高质量发展，助力健康中国建设。

（于德华）

思考题

1. 健康管理的定义是什么？
2. 如何基于全科医学思维开展健康管理？
3. 健康管理的主要内容和实施步骤包含哪些？
4. 如何理解主动健康的内涵？
5. 阐述主动健康管理的相关主体职责以及工作策略。

思考题解题思路　　本章目标测试　　本章思维导图